



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 20 — Dor Abdominal Aguda: abdome cirúrgico × clínico, apendicite, colecistite/colangite, pancreatite, obstrução intestinal, diverticulite, isquemia mesentérica, aneurisma roto e causas ginecológicas

Red flags, analgesia precoce, escores (Alvarado/AIR, Tokyo, BISAP), papel do POCUS sem TC, quem opera e quem observa — cenário: pronto-socorro sem cirurgião, sem TC; cirúrgico/ginecológico → Santa Casa de Mogi Guaçu

Código	PS-ND-20	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Dor abdominal é 5-10% dos atendimentos do PS; 20-25% dos idosos com dor abdominal têm doença cirúrgica e 1/3 dos diagnósticos iniciais no idoso estão errados. Sem cirurgião nem tomografia, a pergunta do PS Natal Diegues não é "qual é o diagnóstico?" mas **"há sinais de abdome cirúrgico, choque, isquemia ou sepse? — se sim, analgesia, ressuscitação, antibiótico quando indicado e transferência para a Santa Casa"**. Este protocolo também combate duas iatrogenias clássicas: **negar analgesia "para não mascarar"** (a evidência mostra o contrário) e dar alta a dor abdominal sem reavaliação e sem plano.

Fontes de ancoragem: Di Saverio S, et al. **WSES Jerusalem guidelines for diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update**. World J Emerg Surg 2020;15:27 [WSES-APE 2020]; Yokoe M, et al. **Tokyo Guidelines 2018**: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis / Kiriya S, et al. TG18 acute cholangitis. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2018;25:41/17 [TG18]; Pisano M, et al. WSES guidelines for acute calculous cholecystitis 2020. World J Emerg Surg 2020;15:61; **Tenner S, et al. ACG Clinical Guideline: management of acute pancreatitis (2024)**. Am J Gastroenterol 2024;119:419 [ACG-PANC 2024]; IAP/APA 2013; Ten Broek RPG, et al. Bologna guidelines for adhesive small bowel obstruction: 2017 update. World J Emerg Surg 2018;13:24 [BOLOGNA 2017]; Sartelli M, et al. WSES guidelines for acute left-sided colonic diverticulitis 2020. World J Emerg Surg 2020;15:32 [WSES-DIV 2020]; Bala M, et al. Acute mesenteric ischemia: WSES guidelines 2022. World J Emerg Surg 2022;17:54 [WSES-AMI 2022]; Sartelli M, et al. WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global consensus on intra-abdominal infections 2021 [WSES-IAI 2021]; Manterola C, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. Cochrane 2011; Colégio Brasileiro de Cirurgiões — Diretrizes de abdome agudo (edição vigente) [CBC — VERIFICAR]; FEBRASGO — Gravidez ectópica / DIP (Orientações e Recomendações).

Convenção de confiança: critérios e doses conforme WSES/TG18/ACG 2024; esquemas antimicrobianos para validação da CCIH [VERIFICAR]. **[VERIFICAR]:** USG/POCUS no PS, lipase/amilase, β -hCG, lactato, RX de abdome agudo, tempo até avaliação cirúrgica na Santa Casa.

1. Queixa — como o paciente chega e o que perguntar

"Dor de barriga forte" é o começo de tudo. A anamnese estruturada em **10 perguntas** orienta 80% dos diagnósticos: (1) **onde começou e onde está** (migração periumbilical → FID = apendicite); (2) **início súbito** (perfuração, ectópica rota, aneurisma, isquemia, torção, cólica) × gradual (inflamatório); (3) tipo — **cólica** (víscera oca: obstrução, biliar, ureteral) × **contínua e piora ao movimento** (peritonite); (4) irradiação — dorso (pâncreas, aneurisma, úlcera posterior), escápula (biliar), virilha (ureter, aneurisma); (5) vômitos (antes da dor = gastroenterite; depois = cirúrgico; fecaloides = obstrução); (6) hábito intestinal — parada de gases e fezes (obstrução), diarreia com sangue (colite, isquemia); (7) febre; (8) **última menstruação, sangramento, corrimento, DIU, laqueadura** (toda mulher em idade fértil); (9) urina; (10) cirurgias prévias (aderências, hérnias), AINE/álcool (úlcera, pancreatite), anticoagulante, FA/cardiopatia (embolia mesentérica), imunossupressão/corticoide/diabetes (sinais atenuados), idade (>65: apresentação atípica).

Padrões que exigem transferência imediata ("os cinco que matam em horas")

Condição	Pistas	Ação no PS
Aneurisma de aorta abdominal roto	>60 anos, tabagista, HAS; dor abdominal/lombar súbita + hipotensão/síncope + massa pulsátil; "cólica renal" pela primeira vez em idoso	POCUS (aorta >3 cm); 2 acessos; hipotensão permissiva (PAS 80-90); sangue; cirurgia vascular imediata
Isquemia mesentérica aguda	Dor intensa desproporcional ao exame , FA/embolia/aterosclerose/baixo débito, idoso; distensão, sangue nas fezes e peritonite são tardios; lactato ↑ (tardio)	Heparina, ressuscitação, antibiótico, angio-TC + cirurgia/vascular em horas
Perfuração de víscera oca	Dor súbita, abdome em tábua, pneumoperitônio ao RX (em pé/decúbito lateral); úlcera, diverticulite, AINE	Jejum, sonda, antibiótico, analgesia, cirurgia
Gravidez ectópica rota	Mulher em idade fértil, atraso menstrual, dor + sangramento + síncope/choque; β-hCG +; líquido livre ao POCUS sem saco gestacional intrauterino	2 acessos, sangue, ginecologia imediata (Santa Casa)
Obstrução com estrangulamento / vólvulo / hérnia encarcerada	Dor contínua (não mais em cólica), febre, taquicardia, peritonismo, hérnia irreduzível dolorosa, leucocitose, lactato	Sonda, volume, antibiótico, cirurgia

2. Clínica — sinais de abdome cirúrgico, escores e principais diagnósticos

2.1 Sinais de alarme (red flags) — qualquer um = abdome potencialmente cirúrgico → Santa Casa

- **Peritonite:** defesa involuntária, rigidez, dor à descompressão (Blumberg), dor à percussão/tosse/salto, paciente imóvel.
- Instabilidade: PAS <90, FC >120, TEC >3 s, confusão, oligúria; sepse (Protocolo 05); lactato >2.
- Dor súbita e intensa ("pior da vida"), dor desproporcional ao exame, dor que acorda, dor >6 h sem melhora com analgesia.
- Distensão com parada de gases e fezes, vômitos fecaloides, hérnia irreduzível, massa pulsátil, sangramento vaginal com choque.
- Idoso, imunossuprimido, diabético, gestante, cirurgia abdominal recente, anticoagulado: limiar mais baixo para imagem e transferência.

2.2 Diagnósticos por quadrante e escores

Diagnóstico	Quadro típico	Escore / critério	Conduta
Apendicite aguda	Dor periumbilical → FID em 12–24 h, anorexia, náusea, febre baixa; McBurney, Rovsing, psoas/obturador; idoso/gestante: atípico	Alvarado (Migração 1, Anorexia 1, Náusea 1, Dor FID 2, Blumberg 1, Febre 1, Leucocitose 2, Desvio 1): ≤4 improvável; 5–6 USG/TC; ≥7 provável. AIR preferido pela WSES. USG: apêndice >6 mm não compressível	Analgesia; jejum; cirurgia (Santa Casa) — antibiótico pré-op (ceftriaxona + metronidazol) ; tratamento não operatório só em não complicada selecionada e por decisão cirúrgica; Alvarado ≤4 com exame normal: alta com reavaliação em 12–24 h
Colecistite aguda	Dor HD/epigástrio >6 h, febre, Murphy +, após refeição gordurosa; mulher, obesa, >40	TG18 : A (Murphy, dor/massa HD) + B (febre, PCR, leucocitose) + C (USG: cálculo, parede >4 mm, Murphy ultrassonográfico, líquido pericolecístico). Grau I leve; II (leucócitos >18.000, massa, >72 h, colecistite gangrenosa/enfisematosa); III (disfunção orgânica)	Jejum, analgesia, antibiótico (ceftriaxona ± metronidazol); colecistectomia precoce (≤72 h) na Santa Casa ; grau III: UTI + drenagem/cirurgia
Colangite aguda	Tríade de Charcot (dor HD + febre + icterícia — 50–70%); pênade de Reynolds (+ hipotensão + confusão) = grave	TG18: inflamação sistêmica + colestase (bilirrubina ≥2, enzimas ↑) + imagem (dilatação/cálculo). Grau III = disfunção orgânica	Antibiótico em ≤1 h (Protocolo 05), volume; drenagem biliar (CPRE) urgente em grave/sem resposta em 24 h — referência com CPRE [VERIFICAR]
Pancreatite aguda	Dor epigástrica intensa em faixa/irradiada ao dorso, vômitos, álcool ou litíase; Cullen/Grey-Turner (tardios)	Diagnóstico = 2 de 3: dor típica + lipase/amilase >3× LSN + imagem. Gravidade: BISAP (BUN >25, alteração mental, SIRS, >60 anos, derrame pleural) ≥3 = grave; disfunção orgânica >48 h = grave (Atlanta 2012)	Hidratação moderada (Ringer lactato 1,5 mL/kg/h ± bólus 10 mL/kg se hipovolemia — WATERFALL 2022; ACG 2024), analgesia (opioide ok), dieta oral precoce (≤24–48 h) quando tolerar, sem antibiótico profilático ; biliar: CPRE só se colangite; colecistectomia na mesma internação; grave/BISAP ≥3/disfunção → UTI (Tabajara Ramos)
Obstrução intestinal	Cólica difusa, distensão, vômitos (biliosos → fecaloides), parada de gases/fezes; cirurgia prévia (aderências 60–70%), hérnia, neoplasia (idoso), vólculo; RH aumentados/metálicos → silêncio	RX: níveis hidroaéreos, distensão, ausência de gás no cólon; TC define causa/estrangulamento (referência); Bologna : sinais de estrangulamento (dor contínua, febre, peritonite, leucocitose, lactato, ausência de contraste no cólon) = cirurgia imediata	Jejum, SNG em sifonagem , volume + K, analgesia; aderencial sem estrangulamento: tratamento conservador 48–72 h com contraste hidrossolúvel (referência); estrangulamento/hérnia/vólculo/completa → cirurgia (Santa Casa)

Diagnóstico	Quadro típico	Escore / critério	Conduta
Diverticulite aguda	Dor FIE contínua ("apendicite do lado esquerdo"), febre, alteração do hábito; >50 anos	TC (Hinchey/WSES): não complicada × complicada (abscesso, perfuração, peritonite)	Não complicada, sem comorbidade, tolera VO: analgesia, dieta líquida, sem antibiótico (WSES 2020) ou amoxicilina-clavulanato 7 dias se comorbidade/imunossupressão; complicada/peritonite/seps → antibiótico IV + cirurgia/drenagem (Santa Casa)
Úlcera perfurada	Dor epigástrica súbita, abdome em tábua, AINE/tabagismo	RX em pé: pneumoperitônio (70-80%); TC	Jejum, SNG, IBP IV, ceftriaxona + metronidazol, analgesia; cirurgia
Cólica renal	Dor lombar em cólica irradiada para genitália, hematúria, inquietação	Protocolo 21; febre + obstrução = urológica urgente	AINE IV; USG; Protocolo 21
DIP / cisto roto / torção ovariana / ectópica	Dor pélvica, corrimento, dor à mobilização do colo (DIP); dor súbita unilateral + massa (torção); atraso menstrual (ectópica)	β-hCG; USG pélvica/transvaginal; leucorreia	DIP leve: ceftriaxona 500 mg IM + doxiciclina 100 mg 12/12 h 14 d + metronidazol; DIP grave/abscesso, torção, ectópica → ginecologia (Santa Casa)
Causas clínicas que simulam abdome cirúrgico	CAD (Protocolo 02), pneumonia de base, IAM inferior (Protocolo 01), herpes-zóster, crise falciforme, porfíria, insuficiência adrenal, hipercalcemia, intoxicação por chumbo, abstinência de opioide, constipação/fecaloma, ITU/pielonefrite	Glicemia, ECG, RX tórax, exame de pele	Tratar a causa; reavaliar

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
Sinais vitais, sensorio, TEC	Choque = ruptura/perfuração/isquemia/seps; febre; taquicardia desproporcional
Inspeção	Distensão (obstrução, ascite), cicatrizes (aderências), hérnias (inguinal, umbilical, incisional — examinar orifícios herniários em todo paciente), equimoses, imobilidade (peritonite) × inquietação (cólica)
Ausculata	RH aumentados/metálicos (obstrução inicial), ausentes (íleo/peritonite tardia), sopro (aneurisma)
Percussão	Timpanismo (obstrução), maciez móvel (líquido), dor à percussão (peritonite), perda da maciez hepática (pneumoperitônio)
Palpação	Superficial → profunda, do lado oposto à dor; defesa involuntária e rigidez = peritonite; Blumberg; Murphy; McBurney/Rovsing/psoas/obturador; massa pulsátil (aneurisma); massa (plastrão, abscesso, tumor, fecaloma); dor desproporcional ao exame (isquemia)
Toque retal / exame ginecológico	Sangue, fecaloma, massa, dor no fundo de saco (abscesso pélvico, apendicite pélvica); mobilização do colo dolorosa (DIP); sangramento vaginal
Genitália externa (homem)	Torção testicular (dor abdominal referida — emergência urológica), epididimite, hérnia
Coluna, flancos, pele	Giordano (pielonefrite/cálculo), zóster, celulite de parede
Reavaliação seriada	Exame repetido a cada 2-4 h pelo mesmo examinador é a ferramenta diagnóstica mais valiosa quando não há TC

4. Propedêutica armada — sem TC, o que existe e o que se transfere

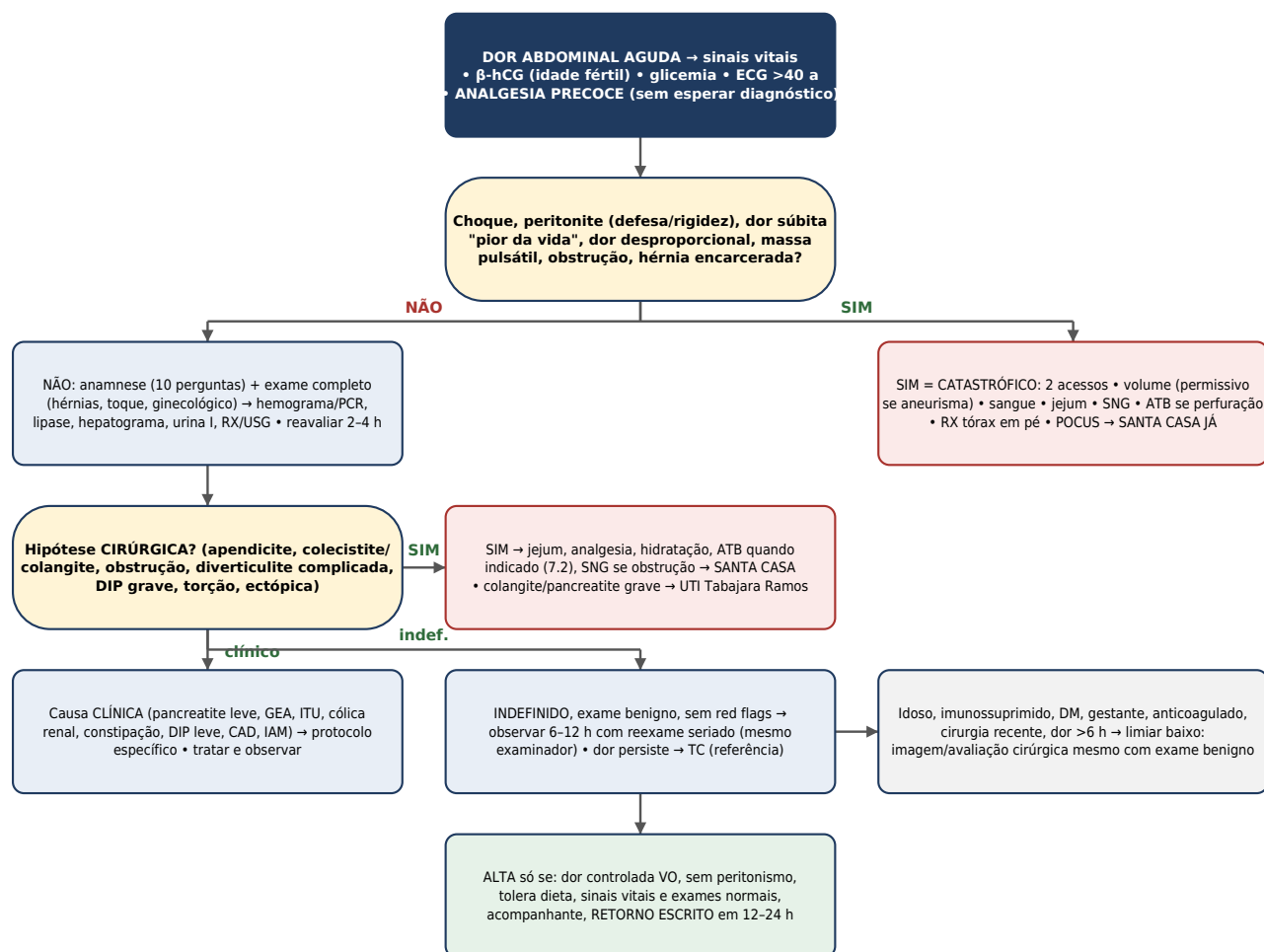
Exame	Para que serve	Quando
β-hCG	Ectópica; muda imagem e fármacos	Toda mulher em idade fértil , antes de qualquer outra coisa
Hemograma, PCR	Leucocitose/desvio (apendicite, colecistite — entram nos escores); PCR <10 e leucócitos normais tornam apendicite improvável (não excluem)	Todos com suspeita cirúrgica
Lipase (ou amilase)	>3× LSN = pancreatite (lipase mais específica); elevação leve em isquemia, perfuração, obstrução, DRC	Dor epigástrica/em faixa [VERIFICAR disponibilidade]
Glicemia, eletrólitos, ureia/creatinina, TGO/TGP, bilirrubinas, FA/GGT	CAD; desidratação (obstrução); colestase (colangite, coledocolitíase); BUN >25 (BISAP)	Conforme quadro
Lactato, gasometria	Isquemia mesentérica (normal não exclui na fase inicial), sepse, estrangulamento	Suspeita de isquemia/estragulamento/sepse
Urina I	ITU/cálculo; hematúria (cálculo, aneurisma); cetonúria	Dor lombar/flanco, disúria
ECG + troponina	IAM inferior com dor epigástrica; FA (embolia mesentérica)	>40 anos com dor epigástrica; fatores de risco
Radiografia: tórax em pé + abdome (em pé e deitado)	Pneumoperitônio (tórax em pé é a melhor), níveis hidroaéreos/distensão (obstrução), vólculo ("grão de café"), cálculo radiopaco, pneumonia de base, corpo estranho; sensibilidade baixa para o resto	Suspeita de perfuração/obstrução; não substitui TC
POCUS / USG de abdome	Líquido livre (hemoperitônio — FAST), aorta >3 cm, colecistite (cálculo, parede >4 mm, Murphy ultrassonográfico), hidronefrose, apêndice (operador-dependente), saco gestacional/ectópica, alças dilatadas, bexiga	Se disponível/treinado — muda a velocidade da transferência [VERIFICAR]
TC de abdome com contraste (padrão-ouro)	Apendicite, diverticulite, obstrução (causa/estrangulamento), isquemia (angio-TC), perfuração, abscesso, aneurisma	Referência ; não retardar a transferência do paciente com peritonite/instabilidade para "fazer TC antes"
Culturas, tipagem	Sepse; cirurgia/choque	Instável/séptico

5. Fisiopatologia (o que a dor conta)

A **dor visceral** vem da distensão, isquemia ou inflamação de víscera oca ou cápsula, conduzida por fibras C bilaterais para o corno posterior: é mal localizada, na linha média, em cólica, com náusea e inquietação — intestino anterior (estômago, duodeno, fígado, pâncreas) no epigástrio; médio (jejuno até cólon transversal, apêndice) no periumbilical; posterior (cólon distal, pelve) no hipogástrio. Quando a inflamação atinge o **peritônio parietal**, innervado por fibras A-delta somáticas, a dor torna-se localizada, contínua, pior ao movimento e acompanhada de defesa — a migração periumbilical → FID da apendicite é a passagem de uma para a outra. A **dor referida** segue dermatômos compartilhados (diafragma → ombro; vesícula → escápula; ureter → virilha; IAM inferior → epigástrio). Na **obstrução**, a distensão progressiva compromete o retorno venoso da parede e depois a perfusão arterial (estrangulamento): a dor muda de cólica intermitente para contínua e surge a peritonite. Na **isquemia mesentérica**, a mucosa (mais sensível) necrosa em 6 h com dor intensa, enquanto o peritônio parietal ainda está íntegro — por isso "dor desproporcional ao exame" e por que lactato e peritonite são achados tardios. Na **pancreatite**, a ativação intraductal da tripsina desencadeia autodigestão e resposta inflamatória sistêmica com sequestro de volume para o retroperitônio — daí a hidratação, mas com moderação (WATERFALL: hidratação agressiva aumentou sobrecarga sem benefício). A **analgesia** não elimina os sinais peritoneais (defesa involuntária persiste) e melhora a acurácia do exame ao permitir a palpação — a Cochrane 2011 e a WSES são unânimes.

6. Fluxo de atendimento [WSES; adaptado ao PS sem cirurgião/TC]

Sequência: **analgesia e triagem de catástrofe** → **anamnese e exame completos** → **hipótese e escore** → **cirúrgico? transfere; clínico? trata; indefinido? observa e reexamina**. A alta exige critérios e retorno escrito.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Chegada → sinais vitais, β-hCG, glicemia, 1ª analgesia	≤30 min
Chegada → exame físico completo documentado (com hérnias/toque/ginecológico quando indicado)	≤1 h
Abdome catastrófico → regulação para a Santa Casa (com ressuscitação em curso)	Imediata — não esperar exames
Suspeita cirúrgica estável → antibiótico (quando indicado) e transferência	≤2-4 h
Indefinido → reavaliação seriada documentada	A cada 2-4 h; decisão em ≤6-12 h
Colangite / sepse abdominal → antibiótico	≤1 h

7. Tratamento — o que fazer no PS

7.1 Analgesia — precoce, sem esperar o diagnóstico [Cochrane 2011; WSES]

Fármaco	Dose	Observações
Dipirona	1-2 g IV lento (criança 15 mg/kg)	1ª linha; dor leve/moderada
Opioide	Morfina 0,05-0,1 mg/kg IV (2-5 mg, repetir a cada 10-15 min) ou fentanil 1 mcg/kg; tramadol 100 mg IV (menos eficaz, náusea)	Dor intensa; não mascara peritonite nem piora acurácia; antiemético junto; cautela em hipotensão/idoso (dose menor)
AINE (cetorolaco 30 mg IV; cetoprofeno 100 mg)	Cólica renal/biliar (1ª linha na renal)	Evitar em DRC, sangramento, úlcera, idoso desidratado, gestante, possível cirurgia (sangramento)
Escopolamina (hioscina) 20 mg IV	Cólica visceral	Não em íleo/obstrução (piora); taquicardia
Antiemético	Ondansetrona 4-8 mg IV; metoclopramida 10 mg IV (não em obstrução)	—
Cetamina em dose analgésica	0,1-0,3 mg/kg IV	Refratária/hipotensão

7.2 Antibióticos empíricos — infecção intra-abdominal [WSES-IAI 2021; TG18] [VERIFICAR com CCIH]

Situação	Esquema (adulto, função renal normal)	Observações
Apendicite / colecistite / diverticulite complicada / perfuração — comunitária, sem sepse	Ceftriaxona 2 g IV/dia + metronidazol 500 mg IV 8/8 h ; ou amoxicilina-clavulanato 1 g IV 8/8 h; ou ampicilina-sulbactam 3 g 6/6 h	Iniciar antes da transferência quando há indicação cirúrgica/perfuração; dose única pré-operatória na apendicite não complicada
Sepse abdominal / choque / IRAS / imunossuprimido	Piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h; ou meropenem 1 g 8/8 h (ESBL/choque) ± vancomicina se enterococo/MRSA	Protocolo 05: ≤1 h; controle do foco em ≤6 h
Colangite	Ceftriaxona 2 g/dia + metronidazol (leve/moderada) → pip-tazo (grave/IRAS)	Drenagem biliar é o tratamento; ATB é ponte
Pancreatite	Nenhum profilático (ACG 2024); ATB só com necrose infectada/colangite documentadas (carbapenêmico na referência)	—
Diverticulite não complicada	Sem antibiótico (WSES 2020) se imunocompetente, sem comorbidade, tolera VO, PCR <150; senão amoxicilina-clavulanato 875/125 12/12 h VO 7 dias	Reavaliar em 48-72 h
DIP leve/moderada	Ceftriaxona 500 mg IM dose única + doxiciclina 100 mg VO 12/12 h + metronidazol 500 mg 12/12 h por 14 dias	Tratar parceiros; testar IST/HIV; grave/abscesso → IV + ginecologia
Isquemia mesentérica	Pip-tazo ou ceftriaxona + metronidazol + heparina (HNF 80 U/kg + 18 U/kg/h)	Cirurgia/vascular imediata

7.3 Medidas por condição

Condição	Medidas no PS antes/durante a transferência
Obstrução intestinal	Jejum; SNG calibrosa (14-16 Fr) em sifonagem/aspiração ; Ringer/SF para repor déficit (frequentemente 2-4 L) + KCl; sonda vesical (diurese $\geq 0,5$ mL/kg/h); antibiótico se estrangulamento/perfuração; analgesia; hérnia encarcerada: tentativa única de redução gentil com sedação/analgesia se <6 h e sem sinais de estrangulamento — senão cirurgia
Pancreatite aguda (leve → observação; moderada/grave → Tabajara Ramos)	Ringer lactato 1,5 mL/kg/h (+ bólus 10 mL/kg se hipovolemia) por 24-48 h, reavaliando a cada 6-8 h (FC, PA, diurese, ureia, hematócrito) — evitar >3-4 L/dia; analgesia (opioide); antiemético; dieta oral pastosa/baixa gordura assim que tolerar ($\leq 24-48$ h) — sem "jejum prolongado"; sem antibiótico; USG de vesícula; álcool: tiamina, abstinência (Protocolo 31); hipertrigliceridemia (>1.000): referência; colangite associada: CPRE
Colecistite / colangite	Jejum, analgesia, antibiótico, hidratação; colecistectomia precoce (≤ 72 h) ou drenagem em alto risco; colangite grave: UTI + CPRE
Apendicite	Jejum, analgesia, hidratação, ceftriaxona + metronidazol pré-operatório; gestante: USG/RM — cirurgia igual
Aneurisma roto	2 acessos calibrosos, tipagem, sangue O negativo se choque, PAS alvo 80-90 (hipotensão permissiva), sem cristaloide excessivo, analgesia, transferência para vascular em minutos — comunicar antes de sair
Gravidez ectópica	2 acessos, tipagem/sangue, Rh (imunoglobulina anti-D se Rh negativo — na referência), ginecologia imediata
Cetoacidose / IAM / pneumonia com dor abdominal	Protocolos 02 / 01 / 10 — não operar o que é clínico
Constipação/fecaloma	Toque retal + extração manual; enema; laxante; investigar causa (opioide, hipotireoidismo, neoplasia em >50 anos com alteração recente)

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir

Situação	Urgência	Destino
Abdome catastrófico: aneurisma roto, isquemia mesentérica, perfuração, ectópica rota, estrangulamento, peritonite difusa, choque	Imediata (ressuscitação em curso; avisar a equipe cirúrgica antes de sair)	Santa Casa de Mogi Guaçu (cirurgia/vascular/ginecologia) — UTI se instável
Apendicite, colecistite, obstrução, diverticulite complicada, DIP grave/abscesso, torção	Mesmo dia ($\leq 2-4$ h), com antibiótico quando indicado	Santa Casa (cirurgia/ginecologia)
Colangite grave, pancreatite moderada/grave (BISAP ≥ 3 , disfunção orgânica), sepse abdominal com disfunção	Imediata	UTI — Tabajara Ramos (CPRE conforme disponibilidade [VERIFICAR])
Dor indefinida persistente >6-12 h sem TC local	Mesmo dia	Imagem (TC) — referência
Pancreatite leve, gastroenterite, ITU, cólica renal não complicada, DIP leve, constipação	Observação/alta	APS com retorno

8.2 Transporte e documentação

- Instável: USA do SAMU 192, 2 acessos, volume/sangue em curso, SNG, monitor, analgesia; posição confortável; nada VO.
- Relatório: **hora de início e evolução da dor**, exame seriado (horários e achados — defesa, Blumberg), sinais vitais seriados, β -hCG, exames (lipase, leucócitos/PCR, lactato, RX/USG com imagem), escore (Alvarado/AIR, TG18, BISAP), analgesia e antibiótico (dose/hora), jejum desde, sonda, comorbidades/anticoagulante, última refeição.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192.

8.3 Alta — critérios e pacote

- Dor controlada com analgesia oral, sem peritonismo em reavaliação, tolera dieta, sinais vitais normais, exames sem alarme, causa provável benigna ou indefinida com baixo risco (Alvarado ≤ 4 , jovem, sem comorbidade).
- Orientação escrita: **retorno em 12-24 h para reexame** (ou imediato se piora, febre, vômitos, dor localizada, parada de gases, sangramento); analgesia simples; dieta leve; sem AINE se úlcera/DRC; sem antibiótico "por precaução".
- Documentar: hipótese, escore, exame normal, orientações e quem acompanha. Dor abdominal com alta é responsabilidade compartilhada — o retorno agendado é parte do tratamento.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de mulheres em idade fértil com β -hCG documentado	100%
% com analgesia em ≤ 30 min da chegada (dor $\geq 5/10$)	$\geq 90\%$
% com exame de orifícios herniários e toque/ginecológico documentados quando indicado	$\geq 80\%$
% de abdome catastrófico com regulação acionada em ≤ 15 min	$\geq 90\%$
% de suspeita cirúrgica com antibiótico (quando indicado) antes da transferência	$\geq 90\%$
% de altas com reavaliação seriada documentada e retorno escrito em 12-24 h	$\geq 90\%$
Antibiótico profilático em pancreatite; jejum > 48 h em pancreatite leve; AINE em possível cirurgia/DRC (eventos)	0 / registrar
Retorno em 72 h com diagnóstico cirúrgico após alta ("apendicite perdida")	Registrar; revisar cada caso

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Escore de apendicite	WSES 2020 prefere AIR/AAS; Alvarado é o mais conhecido no Brasil. Listados ambos; nenhum substitui a imagem/reavaliação
Tratamento não operatório da apendicite	WSES: opção em não complicada selecionada (CODA: 30% falham em 90 dias); decisão do cirurgião — o PS não decide
Hidratação na pancreatite	IAP/APA 2013: agressiva; WATERFALL 2022/ACG 2024: moderada (1,5 mL/kg/h). Adotada moderada
Antibiótico na diverticulite não complicada	WSES 2020/AGA: sem ATB em selecionados; prática brasileira: ATB. Adotado sem ATB com critérios estritos e retorno
Hipotensão permissiva no aneurisma	Consenso vascular (PAS 70-90); sem RCT. Adotado PAS 80-90
Analgesia opioide antes do diagnóstico	Cochrane/WSES: segura; crença antiga: mascara. Adotada analgesia precoce
Redução de hérnia encarcerada no PS	Tentativa única, gentil, com sedação, só se < 6 h e sem estrangulamento — divergência entre serviços; pactuar com a cirurgia
CPRE, TC, USG 24 h	Disponibilidade na referência [VERIFICAR] — define tempos de transferência
Diretriz CBC de abdome agudo	Edição vigente a confirmar [VERIFICAR]

10. Referências

- Di Saverio S, Podda M, De Simone B, et al. Diagnosis and treatment of acute appendicitis: 2020 update of the WSES Jerusalem guidelines. *World J Emerg Surg* 2020;15:27. CODA Collaborative. A randomized trial comparing antibiotics with appendectomy for appendicitis. *N Engl J Med* 2020;383:1907-1919.
- Yokoe M, Hata J, Takada T, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci* 2018;25(1):41-54. Kiriya S, Kozaka K, Takada T, et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholangitis. *J Hepatobiliary Pancreat Sci* 2018;25(1):17-30. Pisano M, et al. 2020 WSES updated guidelines for the diagnosis and treatment of acute calculous cholecystitis. *World J Emerg Surg* 2020;15:61.
- Tenner S, Vege SS, Sheth SG, et al. American College of Gastroenterology Guidelines: management of acute pancreatitis. *Am J Gastroenterol* 2024;119(3):419-437. de-Madaria E, et al. Aggressive or moderate fluid resuscitation in acute pancreatitis (WATERFALL). *N Engl J Med* 2022;387:989-1000. Working Group IAP/APA. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. *Pancreatology* 2013;13:e1-e15.
- Ten Broek RPG, Krielen P, Di Saverio S, et al. Bologna guidelines for diagnosis and management of adhesive small bowel obstruction (ASBO): 2017 update. *World J Emerg Surg* 2018;13:24. Sartelli M, et al. 2020 update of the WSES guidelines for the management of acute colonic diverticulitis in the emergency setting. *World J Emerg Surg* 2020;15:32. Bala M, et al. Acute mesenteric ischemia: updated guidelines of the WSES. *World J Emerg Surg* 2022;17:54. Sartelli M, et al. WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global clinical pathways for patients with intra-abdominal infections. *World J Emerg Surg* 2021;16:49.
- Manterola C, Vial M, Moraga J, Astudillo P. Analgesia in patients with acute abdominal pain. *Cochrane Database Syst Rev* 2011;(1):CD005660.
- FEBRASGO. Gravidez ectópica; Doença inflamatória pélvica (Orientações e Recomendações). Ministério da Saúde. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com IST (DIP), edição vigente. Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Diretrizes de abdome agudo (edição vigente) [VERIFICAR].
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de dor abdominal (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração